DESCRIPCIÓN DE CIRUGÍAS

IDENTIFICACIÓN

Paciente: JAVIER ORLANDO PELAEZ MONTOYA **Identificación** CC 17038267
Edad: 85 AÑOS **Empresa:** EPS SANITAS REGIMEN SUBSIDIADO-2025
Sala: SALA DE ENDOSCOPIA **Fecha programación de cirugía:** 05/11/2026

Sede de Atención: SEDE PRINCIPAL

CIRUGÍAS

CANT	CÓDIGO	NOMBRE DE LA CIRUGÍA	Grupo Quirúrgico	UVR
1	**452305**	**COLONOSCOPIA TOTAL CON O SIN BIOPSIA**	Y57	

Cirujano: ALVARO SALAZAR CORREA **Especialidad:** CIRUGIA GASTROINTESTINAL Y ENDOSCOPIA DIGESTIVA
Vía:

DESCRIPCIÓN CIRUGÍA

CIRUJANO ES269 ALVARO SALAZAR CORREA **Especialidad** CIRUGIA GASTROINTESTINAL Y ENDOSCOPIA
452305 **COLONOSCOPIA TOTAL CON O SIN BIOPSIA**
Dx Preoperatorio: R104 OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS

Dx Postoperatorio: K573 ENFERMEDAD DIVERTICULAR DEL INTESTINO GRUESO SIN PERFORACION NI ABSCESO

Tipo de Herida: LIMPIA **Tipo de Anestesia:** SEDACION **Tipo de Cirugía:** URGENCIAS
Cantidad de Sangrado: 0 **ml.** **Vía:** UNICA VIA
Clasificación de riesgo quirúrgico : **A.S.A :** 0 **NNIS :** 0
Realización Acto Quirúrgico: **Fecha Inicio** 05/11/26 **Fecha Final** 05/11/26
Hora Inicio 14:50:00 **Hora Final** 15:00:00
Tiempo de Perfusión: 0 **Minutos** **Tiempo de Clamp:** 0 **Minutos**

Descripcion Quirúrgica:
PREVIA EXPLICACION DEL PROCEDIMIENTO, SUS RESPECTIVOS RIESGOS, POSIBLES COMPLICACIONES Y VERIFICACION DE CONSENTIMIENTO INFORMADO FIRMADO, SE COMPRUEBA QUE TODO EL PERSONAL QUE ACTUARA EN ESTE PROCEDIMIENTO CUENTE CON LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) , SE PROCEDE A UBICAR EL PACIENTE EN DECUBITO LATERAL IZQUIERDO. A CONTINUACION SEDACION IV SUMINISTRADA POR ANESTESIOLOGO. SE INTRODUCE COLONOSCOPIO HASTA COLON CECAL, SIN ACCIDENTES Y EN RETROVISION SE DESCRIBEN HALLAZGOS.. SE DA POR TERMINADO EL PROCEDIMIENTO CON EL PX ESTABLE Y SIN COMPLICACIONES.
"TACTO RECTAL: ORIFICIO ANAL SIN ALTERACIONES APARENTES. ESFINTER NORMOTONICO, AMPULA RECTAL VACIA, GUANTE SALE LIMPIO, SE INICIA RETROVISION OBSERVANDO, ABUNDANTE MATERIAL DE RESIDUO LIQUIDO COLON CECAL Y ASCENDENTE; SANGRE DE APARIENCIA RECIENTE Y COAGULOS EN COLON SIGMOIDE Y COLON RECTAL , (2-3-2) PUNTAJE 7/9 BOSTON, LO CUAL IMPIDE UNA OPTIMA VALORACION DE LAS CARACTERISTICAS DE SU MUCOSA. MUCOSA DE RECTO SIN ALTERACIONES APARENTES. EN MUCOSA DE COLON CECAL, COLON ASCENDENTE, COLON TRANSVERSO, COLON DESCENDENTE Y SIGMOIDES, MULTIPLES LESIONES SACULARES DE 3 A 5 MM DE DIAMETRO
"
IMAGEN COMPATIBLE CON: 1) ENFERMEDAD DIVERTICULAR UNIVERSAL CON ESTIGMAS DE SANGRADO RECIENTE

Complicaciones : **SI** ☐ **NO** ☒

Tejidos enviados a patología : **SI** ☐ **NO** ☒

ALVARO SALAZAR CORREA
Reg. 13145
CIRUGIA GASTROINTESTINAL Y ENDOSCOPIA DIGESTIVA

*** * * FIN DEL REPORTE * * ***